جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : شيماء محمود حنفي احمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** اللبن
رقم البطاقة : 29304172101346 **رقم التليفون :** 01146810696 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-04-1993 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تاموكسيفين علاج هرموني [14160] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شيماء محمود حنفي احمد
National ID: 29304172101346

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Tamoxifen hormonal therapy.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS

تعبير



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

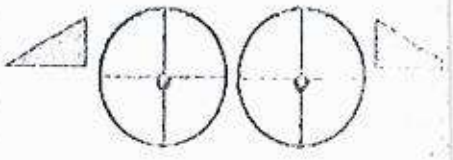
البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

-Patient ID:
- Name : فرتاء محمود عاطف احمد Sex: Female 3- Medical number: 83114037 Old Kad : 401-2023

-ID number: 29304172101346 Patient Age : 30 Y

MDT



amily history		Phone	01146800696 01229166655	BMI		REASON OF MDT	POST OPERATIVE
arital status :		NRS Score		GROUP	A	Date of MDT	2023-09-09
o morbidity	FREE	Menopausal status	PREMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup : CTCAP-->FREE

HX: IDC	ER: 7/8	PR: 7/8	Her 2 Neu : 2	FISH : Amplified	Ki67 : 35

T 2	N 0	M 0

Mammography

PATIENT HISTORY

CASE OF LT IDC STARTED NACT 6 CYCLES+2 CYCLES HP
CLINICALLY MASS FELT OVER THE INNER QUADRANT ALMOST STATIONARY
LT WLE & axillary dissection:
free margin , free LN 0/11 , partial pathological response
T1a N0

MDT OUTCOME & PLAN

for TDM1 to complete 1 y, PORT, zoladex/Tam 5 ys

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/هالة الغزالي	RADIOLOGY	٥-٩/٩/٢٠٢٣
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: شيماء محمود حنفي	
MR. : 8317	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient presented for administration of Zoladex 10.8 mg, tamoxifen, and supportive treatment planned for a duration of three months.

The patient has a history of left-sided breast cancer that was estrogen-receptor positive (7/8), progesterone-receptor positive (7/8), HER2-positive (2+ amplified), with a Ki-67 index of 35 %. Six cycles of TCHP were administered in 2019, followed by left total mastectomy with wide local excision and sentinel lymph node biopsy in August 2023, revealing ypT1a, ypN0 disease. Adjuvant therapy with 12 cycles of Kadcyla was then given via a port, and the patient continues on hormonal therapy with tamoxifen, Zoladex, and supportive care. The patient has completed 12 cycles of adjuvant Kadcyla.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Reham Ahmed Fathy Ibrahim

يعتمد ,

Kasr El-Ainy Center of Radiation Oncology and Nuclear Medicine

Faculty Of Medicine, Cairo University

"NEMROCK"

Nuclear Medicine Unite

مركز قصر العيني

لعلاج الأورام والطب النووي

كلية الطب - جامعة القاهرة

(نمروك)

Report

Patient Name:	Shaimaa Mahmoud Hanafi Ahmed	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q35577	DATE:	2/21/2023 9:33:33 AM

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of left breast cancer, for assessment.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- Uniform tracer uptake is seen allover the skeleton with no features of bone metastasis detected.

Opinion

- **No scintigraphic evidence of metastatic bone lesions.**

Dr. Ahmed Badawy, MD

Dr. Ferdaws Badr

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Presidential Initiative for Women's Health

Pathology Lab - Cairo University Hospitals

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

مستشفيات جامعة القاهرة

PATHOLOGY REPORT

Name: شيماء محمود حنفي احمد

Patient's I.D :29304172101346

Age: 30 Y

Clinical data: Left breast mass.

Nature of the specimen: U.S. Guided Tru Cut Biopsy.

Pathology Number: 10/2023

Specimen Received Data: 10 / 01 /2023

Date Report Issued: 14/ 01 /2023

GROSS EXAMINATION: Tissue core biopsy, totally submitted.

MICROSCOPIC EXAMINATION: Serial sections examined revealed cores of malignant tumor formed of frequent tubules & groups of moderately anaplastic epithelial cells, surrounding desmoplastic stroma with poor TILs was seen. Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ component (cribriform, papillary & comedo) was also seen.

DIAGNOSIS: Left Breast Mass, U.S. Guided Tru Cut Biopsy:

- Invasive Duct Carcinoma, NST, Grade II.

DR. SARA ABOU-FANDOUD
DR. AYA MAGDY

Sara
A. Magdy

Presidential Initiative for Women's Health

Pathology Lab - Cairo University Hospitals

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

مستشفيات جامعة القاهرة

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

NAME: شيماء محمود حلمي احمد

PATIENT'S I. D.: 29304172101346

AGE: 29 Y.

TM : 10 SISH /2023

Specimen Received Data: 29 / 01 /2023

Date Report Issued: 04/ 02 /2023

CLINICAL DATA: A case of *left* breast cancer, for detection of HER2 amplification by dual in situ hybridization (DISH).

PROCEDURE: Tissue sections from paraffin block were used for quantitative detection of HER2 amplification using Ventana Benchmark Ultra System autostainer & VENTANA INFORM HER2 Dual DNA Probe Cocktail Assay.

RESULTS:

The HER2 NEU/ CEP 17 ratio was 3.425

HER2 copies were 6.86

COMMENT:

HER2 Status by DISH: *AMPLIFIED*

DR. PASSANT ESSAM SHIBEL

DR. AYA MAGDY

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Presidential Initiative for Women's Health

Pathology Lab - Cairo University Hospitals

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

مستشفيات جامعة القاهرة

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Name: شهاء محمود حنفي احمد
PATIENT'S I.D :29304172101346
Age: 30 Y

TM: 10 /2023
Specimen Received Data: 16 / 01 /2023
Date Report Issued: 24/ 01 /2023

CLINICAL DATA: A case of *left* breast cancer, for estrogen, progesterone receptors, Her-2/neu and Ki-67.

PROCEDURE: Sections from paraffin block were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclonal antibodies for estrogen, progesterone & Her-2/neu, (CONFIRM™ anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM™ anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2), CONFIRM™ anti-HER-2/neu (4B5) Primary Antibody), and CONFIRM anti-Ki67 (30-9) Primary Antibody), using Ventana IView™ system. DAB was used as a chromogen and hematoxylin as a counter stain.

RESULTS:
Examination of section treated for estrogen receptors revealed strong positive nuclear staining in 60% of tumor cells by chromogen.
Examination of section treated for progesterone receptors revealed strong positive nuclear staining in 50% of tumor cells by chromogen.
Examination of section treated for Her-2/neu revealed moderate complete membrane staining in >10% of tumor cells by chromogen (score 2+).
Examination of section treated for Ki67 revealed positive nuclear stain in average of ±35% of tumor cells.

CONCLUSION:

Tumor Cells Were:

- ***Positive*** **For Estrogen Receptors, Score 7/8.**
- ***Positive*** **For Progesterone Receptors, Score 7/8.**
- ***Equivocal*** **For Her-2/neu (Score 2+)**
- **35% Proliferative index**

COMMENT: *All controls show appropriate reactivity.*

Prof. Dr. Ahmed Abdel Aziz

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Cairo university –faculty of medicine
Cairo university hospital
Radiology department

جامعة القاهرة –كلية الطب
مستشفيات جامعة القاهرة
قسم الاشعة التشخيصية

Patient name english: SHAYMIA MAHMOUD HANFY	Age: 30 Years
Study Date: 1/12/2023 11:51:39 AM	Patient id: 101346

GIT IMAGING UNIT

POST CONTRAST CT EXAMINATION OF ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

***Given history of breast cancer patient.*

- The liver is mildly enlarged showing smooth outline and homogenous parenchymal texture with no focal lesion. No dilated intra hepatic biliary radicles.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, IVC , aorta and pelvic organs.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes .
- Average filled urinary bladder with no masses or diverticular outpouching.
- No ascites or pelvic collection.
- Left femoral head small bone island.

OPINION:-

- Mild hepatomegaly. No metastatic focal lesions.

Dr. Noha El-Mansy MD

Dr. Mahmoud Mekhaimar, MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Bilateral Full Field Mammography with Complementary Ultrasound Examinations Revealed

Background: left palpable lump 6 months ago.

Findings:

- Scattered fribroglandfular tissue is seen (ACR B).
- Left breast LIQ irregular shaped hyperdense speculated mass lesion is seen.
- Complementary Ultrasound
- Left breast 7 o'clock irregular hypoechoic speculated mass lesion is seen with surrounded desmoplastic reaction measuring collectively about 4x 2.3 cm with related intraductal extension for about 2.6 cm.
- Left breast outer single view asymmetry is seen with no definite lesions by ultrasound.
- No right solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Bilateral non specific axillary lymphadenopathy.
- Prominent small subcentimeteric internal mammary lymph node measuring about 7mm

Opinion:

- Left breast LIQ highly suspicious mass lesion with intraductal extension as described and prominent internal mammary lymph node (BIRADS 4c).
- Left outer quadrant single view asymmetry.
- For further CEM and histopathology

Thanks for reference

Dr. Safaa ibrahim, MD

Dr. Mennatallah M.Hanafy, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]